



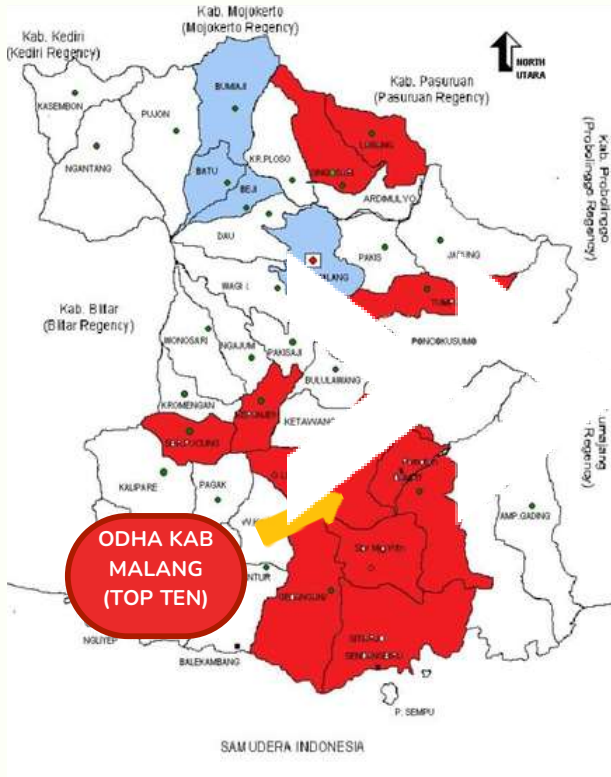
“KEPANJEN : Kelompok Peduli HIV dan AIDS Jenius Kompeten”

Kategori IV : Inovasi Sosial Budaya dan Kependudukan

Oleh : Tri Nurhudi Sasono,
Galuh Kumalasari, Ainun Hurrotaini
Arfina Juliasari Irianto



Latar Belakang



Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah HIV/AIDS tertinggi (Sebanyak 543.100 individu yang hidup dengan HIV/AIDS tahun 2020).

Provinsi Jawa Timur menjadi daerah tertinggi kasus prevalensi HIV-AIDS di Indonesia yaitu sebesar 214.819 ODHA dan dilaporkan hanya 180.843 orang yang mengakses pengobatan terapi ARV. Kabupaten Malang dengan jumlah kasus 2.989 ODHA menempati posisi kedua tertinggi di Jawa Timur setelah Kota Surabaya.



kelompok dukungan sebaya sangat penting



Ketidakpatuhan pengobatan

Lost Follow Up (LFU) untuk pengobatan dan ART sebesar 21,87%.



Stigma dan diskriminasi terhadap orang positif HIV



Keterbatasan akses layanan kesehatan
dan obat ARV.



Kurangnya pemahaman tentang pentingnya minum obat bagi orang positif HIV



Keterbatasan ekonomi
dan sosial

Tujuan

- Memutus mata rantai penularan HIV/AIDS
- Meningkatkan kualitas hidup ODHA
- Menghilangkan Stigma diskriminasi pada ODHA

Manfaat

1. Deteksi dini penemuan kasus HIV/AIDS secepat mungkin dan penanganannya
2. Manajemen pengobatan HIV/AIDS secara jangka panjang
3. Memberdayakan kelompok peduli AIDS.



TIMELINE PENGEMBANGAN INOVASI

Waktu Uji Coba : Januari – Mei 2023

Waktu Penerapan : Juni- Oktober 2023

Waktu Pengembangan : Desember 2023- April 2024

PENGHARGAAN DARI BUPATI MALANG

KEPADA

**TRI NURHUDI SASONO,S.Kep.,Ns.,M.Kep
(YAYASAN CAHAYA KASIH PEDULI WPA TUREN)**

Sebagai

**PENDAMPING PEMBERDAYAAN WARGA PEDULI
HIV-AIDS DI KABUPATEN MALANG**

Tahun 2023



Intervensi dan inovasi

Ketidakpatuhan pengobatan pada orang HIV positif

- Peningkatan pemantauan dan dukungan sosial
- Penyedia layanan konseling
- Instrumen Tabel monitoring minum obat

Stigma dan diskriminasi terhadap orang positif HIV

- Dukungan psikologis
- Kampanye edukasi pemahaman masyarakat

Keterbatasan akses layanan kesehatan dan obat ARV.

- Peningkatan aksesibilitas layanan
- Subsidi obat ARV

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya minum obat bagi orang positif HIV

- Kampanye edukasi obat ARV
- Penyediaan sumber informasi

Keterbatasan ekonomi dan sosial

- Motivasi pengobatan dan penghidupan kembali usaha kecil yang sudah ada

Form 1: Monitoring Minum Obat

Bulan dan Tahun: _____

Tanggal ambil obat bulan ini : _____

Tanggal ambil obat berikutnya : _____

Dalam sehari aku minum obat _____ kali pada pukul _____

Tanggal	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
MINGGU I							
Tanggal							
MINGGU II							
Tanggal							
MINGGU III							
Tanggal							
MINGGU IV							
Tanggal							
MINGGU V							

Gejala yang dialami saat minum obat : _____

Motivasi untuk tetap minum obat : _____

Form 2: MIB MENGEJAR IMPIAN, BISA!

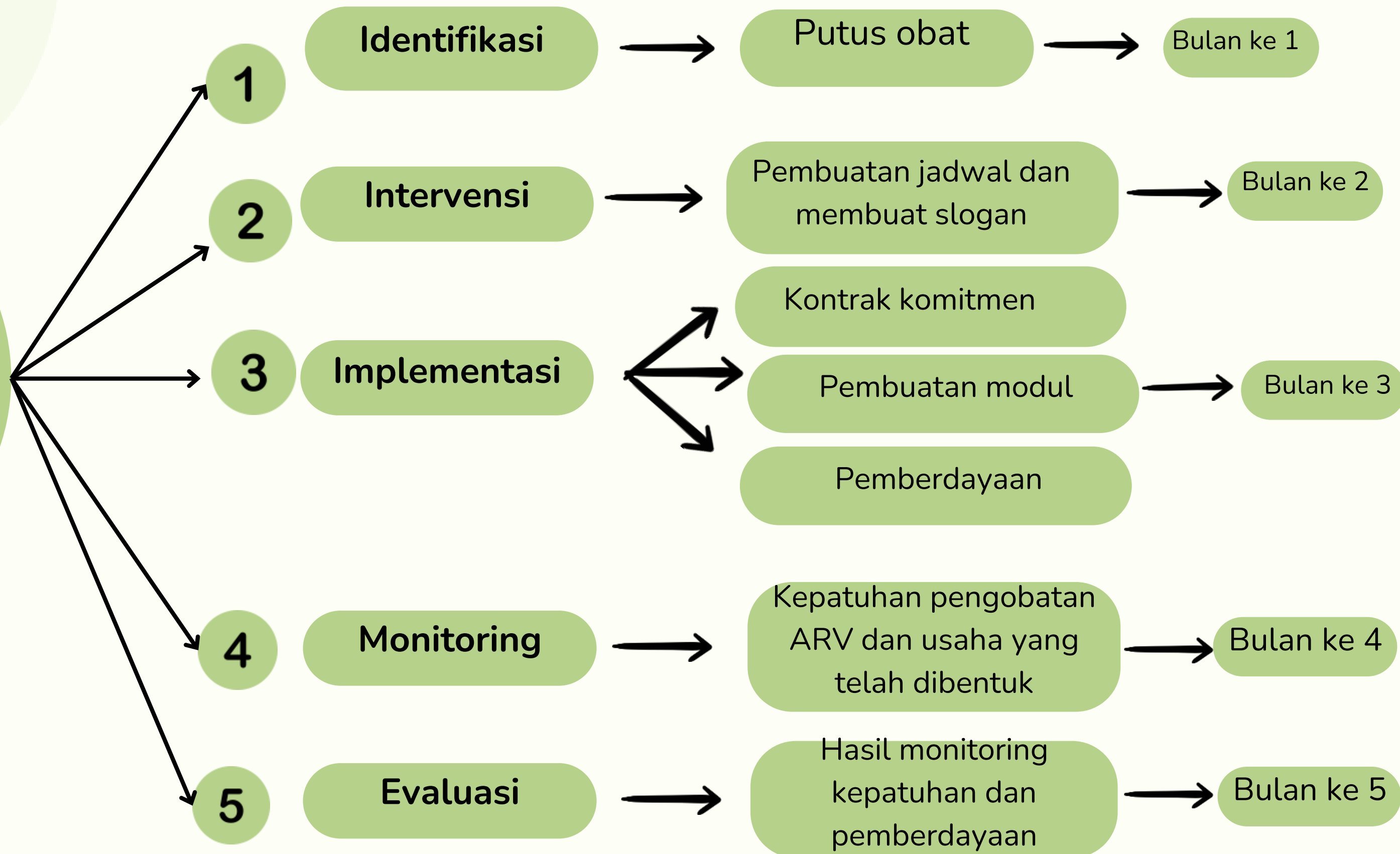
20. _____

AKU PASTI BISA:

3 bulan	6 bulan
1 tahun	3 tahun
5 tahun	10 tahun

Gejala yang dialami saat minum obat : _____

Motivasi untuk tetap minum obat : _____



**Pemberdayaan pada Orang Dengan HIV AIDS Bersama Inovasi
KEPANJEN**



Pemberdayaan Pembuatan Kopi dampit asli malang

Pemberdayaan pada Orang Dengan HIV AIDS Bersama Inovasi KEPANJEN



Pemberdayaan Minat dan Bakat
kesenian Ludruk



Pemberdayaan pada Orang Dengan HIV AIDS Bersama Inovasi KEPANJEN



Pemberdayaan Minat dan Bakat
Produksi pembuatan Batik



THANK YOU